

УДК: 616-006.6-01(574)

Д.М. Байпеисов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Управление стратегическими преобразованиями в онкологической службе Республики Казахстан

Аннотация. С 2012 года в Республике реализуется Программа развития онкологической помощи в РК на 2012 - 2016 годы. Эффективность проводимых в онкологической службе стратегических изменений зависит от многих факторов. В том числе управление данными преобразованиями. Руководителям управлений здравоохранения, онкологических диспансеров, амбулаторно-поликлинических организаций необходимо обладать соответствующими навыками и знаниями по достижению поставленных целей и задач. Анализ проводимых в онкологической службе реформ показал наличие проблем обусловленных недостаточной проработкой механизмов исполнения и реализации, неготовностью персонала медицинских организаций к изменениям. Оценка исполнения запланированных мероприятий усложнялась отсутствием эффективной системы мониторинга.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкологическая служба, стратегические преобразования, менеджмент в здравоохранении.

Актуальность. В марте 2012 года Постановлением Правительства РК утверждена Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы. Целью Онкопрограммы является повышение ожидаемой продолжительности и качества жизни казахстанцев путем снижения смертности населения от онкологических заболеваний. Основными задачами определены: совершенствование профилактики онкологических заболеваний путем развития программ ранней диагностики (скринингов), повышение доступности высокотехнологичных методов диагностики и лечения с научно-обоснованной эффективностью, создание современной системы реабилитационной и паллиативной помощи онкологическим больным.

Реализация Онкопрограммы способствовала улучшению профилактики онкологических заболеваний. На сегодняшний день по Республике реализуются 6 скрининговых программ ранней диагностики злокачественных новообразований, внедряется вакцинация девочек подростков против вируса папилломы человека. Большое внимание уделяется повышению квалификации врачей онкологической службы. Врачи организаций ПМСП обучаются вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Внедряются новые методы диагностики и лечения ЗН. Онкологические организации оснащаются современной лечебно-диагностической аппаратурой. Открываются новые онкологические, маммологические и проктологические кабинеты и кабинеты амбулаторной химиотерапии. Увеличивается число коек для оказания паллиативной помощи.

На эффективность проводимых в онкологической

службе стратегических изменений имеют влияние многие факторы, в том числе управление данными преобразованиями. Руководители территориальных управлений здравоохранения, онкологических диспансеров, амбулаторно-поликлинических организаций должны обладать соответствующими знаниями и навыками по достижению поставленных целей и задач. Анализ проводимых в онкологической службе реформ показал наличие проблем обусловленных недостаточной проработкой механизмов исполнения и реализации, неготовностью персонала медицинских организаций к изменениям. Оценка исполнения запланированных мероприятий усложнялась отсутствием эффективной системы мониторинга. Целью исследования является разработка методики внедрения и управления стратегическими преобразованиями в онкологической службе Республики Казахстан.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Дать объективную оценку состояния и существующих проблем онкологической службы Республики.

Определить основные задачи и тенденции развития онкологической службы Республики в современных условиях.

Разработать систему мониторинга и оценки деятельности онкослужбы.

Разработать рекомендации по управлению стратегическими изменениями в онкологической организации.

Для решения поставленных задач в исследовании были применены следующие методы: комплексный и системный методы, метод сравнительного анализа, метод прогнозирования, диалектико-логический метод, графический метод.

При изучении проблемы использовались официальные материалы, законодательные и нормативно-правовые акты, материалы ГПРЗ РК «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы, Программа развития онкологической помощи населению РК на 2012 – 2016 годы, научные статьи, материалы научно-практических конференций, статистические сборники, статистические данные онкологических организаций.

Целесообразность и осуществимость стратегических преобразований в онкологической организации проверяется на подготовительном этапе, включающем в себя: определение стратегических целей, анализ целевых перспектив изменений по модели OBSC, проверку осуществимости при помощи PEST – анализа, SWOT – анализа.

Планирование стратегических преобразований в онкологической организации начинается с выбора ключевых факторов успеха (КФУ) и ключевых показателей

эффективности (KPI). КФУ позволяют охарактеризовать внутреннюю и внешнюю среду организации, охватывая различные ее аспекты. KPI предназначены для количественной оценки критических факторов успеха. Каждый КФУ оценивается от одного до трех факторами эффективности.

В онкологической организации планируются преобразования внутренней среды, касающиеся структуры, управления и организации лечебно-диагностических процессов, но приоритетными должны стать изменения организационной культуры и личного видения медицинских работников. Во внешней среде должны быть осуществлены изменения, способствующие повышению уровня удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг и достижению международного рейтинга.

Ключевыми факторами успеха (КФУ) онкологической организации определены:

1. Высокий уровень оказания онкологической помощи.
2. Наличие современной материально-технической и технологической базы онкологической организации.
3. Высокий профессиональный уровень медицинских работников.
4. Прибыльность.

С учетом вышеуказанных факторов определены следующие ключевые показатели эффективности (KPI) онкологической организации:

- количество онкологических больных получивших лечение в условиях стационара;
- количество внедренных методов диагностики и лечения 3Н;
- рейтинговое место среди медицинских или научных организаций;
- показатель рентабельности предприятия.

KPI учитывают и объединяют общие показатели деятельности медицинской организации и личные показатели медицинских работников ЛПУ. Мониторинг ключевых показателей эффективности проводится на постоянной основе, поэтому выбрана модель TPS позволяющая осуществлять стратегические преобразования непрерывно.

Следующим шагом после определения целей изменений и доказательств выполнимости необходимо перевести цели преобразований в задачи. Для этого применяется метод MBO (ManagementByObjectives), позволяющий управлять сотрудниками и предприятием. Метод способствует формулировке целей и задач направленных на реализацию стратегического плана организации, проведению контроля за их выполнением и оценке результативности и эффективности персонала и структурных подразделений. Кроме того метод MBO позволяет распределить поставленные задачи между работниками. Реализация метода проводится сверху вниз.

При формулировке задач учитывалась специфика медицинской организации и охватывался комплекс различных направлений и принципов деятельности:

- социальная ориентированность и ответственность;
- научная направленность;
- лечебно-диагностические мероприятия;
- управление ресурсами (трудовыми, финансовыми,

- информационными, медицинским оборудованием);
- новые технологии;
- прибыль и рентабельность предприятия.

На следующем этапе сформулированные задачи раскладываются на управленческие рабочие задания (УРЗ). Структуру управленческих рабочих заданий должны определять шаги, которые необходимо предпринять, и вклад, который необходимо сделать ради достижения целей организации.

Когда задачи сформированы, производится их перевод в управленческие технические задания (УТЗ).

Согласно управленческих рабочих заданий разрабатывается план изменений, являющийся своего рода «дорожной картой» по достижению поставленных целей. В плане указываются конкретные сроки исполнения, форма завершения и определяются ответственные лица.

Таким образом, производится перевод стратегических целей организации в конкретные задачи, трансформация их в управленческие рабочие задания и мероприятия с определением ответственных лиц из числа сотрудников организации.

Заключение

1. Анализ проводимых в онкологической службе Республики изменений подтверждает научную точку зрения о том, что стратегическое развитие организаций – это эволюционный процесс, характеризующийся непрерывностью, т.е. одно стратегическое изменение является основанием или предпосылкой для других изменений. В большинстве случаев это процесс ступенчатого характера.

Установлено, что стратегия изменений онкологической службы может быть единой и охватывать деятельность всех ООД. В то время, как нет единого универсального рецепта проведения этих изменений в организации. Стратегия изменений каждой отдельной онкологической организаций является уникальной, индивидуальной и составляется с учетом уровня оказания медицинской помощи, потенциала и укомплектованности кадрами, культурной среды, материально-технического оснащения и других имеющихся ресурсов.

2. Проведенный анализ состояния онкологической службы позволил выявить ключевые проблемы:

- недостаточно эффективная работа по профилактике и ранней диагностике 3Н;
- недостаточное развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических больных;
- дефицит кадров онкологической службы;
- недостаточно развитая инфраструктура и материально-техническое оснащение онкологической службы;
- слабое развитие паллиативной и реабилитационной помощи.

3. С учетом выявленных ключевых проблем определены основные задачи и тенденции развития онкологической службы на 2016 – 2020 годы:

- совершенствование профилактической направленности системы ПМСП;
- развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- укрепление и развитие кадрового потенциала;

- совершенствование инфраструктуры онкологической службы и укрепление ее материально-технической базы;

- развитие паллиативной и реабилитационной помощи

4. Для повышения эффективности деятельности онкологической службы РК, улучшения взаимодействия и преемственности в деятельности УЗ, республиканских и региональных онкологических организаций необходимо внедрение системы мониторинга и оценки деятельности службы, с созданием национальной (1), региональных (18) и районных (во всех ЦРБ) групп МиО.

5. На основе модели управления стратегическими преобразованиями в онкологической службе, подготовленной на примере КазНИИОиР, разработаны рекомендации по управлению стратегическими изменениями в онкологической организации.

Реформирование системы здравоохранения проводимое в рамках реализации ГПРЗ «Саламатты Казахстан»

требует профессионального подхода со стороны руководителей всех уровней и звеньев.

Управление изменениями является обязательным условием при проведении стратегических, организационных преобразований в онкологической службе в целом и онкологических организациях в частности. Главной задачей управления стратегическими изменениями в онкологических организациях является максимальная адаптация всех структурных подразделений, ресурсов и бизнес-процессов к новым условиям работы, внешней среды. А так же адаптация планов и действий медицинского персонала и сотрудников по планированию, организации, контролю и мотивации проводимых преобразований на всех уровнях.

Для проведения эффективных стратегических преобразований в онкологической службе необходимы дальнейшие организационные изменения.

Список литературы

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.
2. Барнс Т., Сталкер Г.М. Менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 467 с.
3. Виханский О., Наумов А. Менеджмент. Учебник. – 3-е изд. – М.: Экономист, 2003. – 364 с.
4. Семенов В. Г. Психология управления. – М.: Изд-о Дальневосточного университета. – Владивосток, 2005. – 250 с.
5. Beer M., Nohria N. Resolving the Tension between Theories E. and O of Change / Breaking the Code of Change // Harvard Business School Press. – Boston, 2000.
6. Фламгольц Э., Рэнд И. Управление стратегическими изменениями от теории к практике – М.: Эксмо, 2012. – 320 с.
7. Андреева Т. Организационные изменения: сравнительный анализ основных подходов // Вестник С-Пб. университета. Серия Менеджмент. – 2004. – Вып. 2.
8. Гибсон Дж., Доннелли Д. Организации: поведение, структура, процессы // Учебник для вузов – Новосибирск.: ИН- ТРА, 2001. – 660 с.
9. Широкова Г.В. Стратегии организационных изменений // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №1.
10. Рамперсад Хьюберт К. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к личному счастью, гармоничному развитию и росту эффективности организации. – М: Олимп-Бизнес, 2005. – 176 с.
11. Коттер Дж., Коэн Д. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации. – М.: Олимп-Бизнес, 2007.

Тұжырым
Д.М. Байпеисов

Қазақтың онкология және радиология
ғылыми-зерттеу институті

Summary
D.M. Baipeisov

Kazakh Research Institute of Oncology and
Radiology

Қазақстан Республикасының
онкологиялық қызметінің
стратегиялық-өркендеушілік
басқармасы

Management of strategic changes in
the Oncology Service of the Republic
of Kazakhstan

2012 жылдан бастан Республикамызда «2012-2016 жылғы онкология қызметінің жетелдіру» программасы енгізіліп жатыр. Онкология қызметінде өткізіліп жатқан стратегиялық реформалардың тиімділігі көптеген факторларға байланысты. Олардың ішінде бұл өзгерістерді басқару. Денсаулық сақтау басқармасы, онкология диспансері, амбулаторлы-поликлиника мекемелер басшыларының қойған мақсатына жету білімдері мен дағдыларына байланысты. Енгізу тәсілдерінің жеткіліксіз дайындығы мен қызметкерлердің өзгеріске қарсыласу қиыншылықтарын, онкология қызметінің реформаларын талдауы көрсетті. Жоспарланған іс-шараларды бағалауы тиімді мониторинг жүйесінің жоқсыздығымен қиыншылыққа тірелген.

Түінді сөздер: Қатерлі ісіктер, онкология қызметі, стратегиялық өзгерістер, денсаулық сақтау менеджменті

Development of cancer service in Kazakhstan 2012-2016" program is continuously implementing in republic from 2012. Effectiveness of ongoing strategic reforms in cancer service depends on many factors, including management of these changes. Management teams of regional healthcare administrations, cancer dispensaries and primary care facilities must have abilities and knowledge for achieving these goals. Analysis of ongoing reforms in cancer service revealed that there is lack of implementation mechanisms and personnel resistance for changes. Evaluation of reform implementation faced difficulties with absence of monitoring mechanisms.

Keywords: Cancer, cancer service, healthcare management, strategic changes.